Manuel de prélèvement

Laboratoire FICTIF des Tilleuls — DOCUMENT FICTIF DE TEST — contenu inventé pour LabGuard, ne pas utiliser pour une pratique réelle. Aucune donnée patient.

Rubrique	Valeur
Code du document	MP-PRE-001
Version	3
Date d'application	01/03/2026
Rédaction	Cellule qualité (fictive)
Approbation	Biologiste responsable (fictif)

Sommaire

- 1. Objet et domaine d’application
- 2. Règles générales de prélèvement
- 3. Tubes utilisés
- 4. Catalogue des analyses
- 5. Cas particuliers et tubes alternatifs
- 6. Critères de non-conformité
- 7. Historique des versions

1. Objet et domaine d’application

Ce manuel décrit les conditions de prélèvement, de conservation et de transport des échantillons biologiques confiés au laboratoire fictif. Il s’applique aux préleveurs internes, aux infirmiers des services de soins et aux coursiers. Toute analyse dont les conditions pré-analytiques ne sont pas respectées peut être refusée.

Les informations de ce manuel priment sur les habitudes de service. En cas de doute sur le tube à utiliser, contacter le secrétariat du laboratoire avant le prélèvement plutôt qu’après.

2. Règles générales de prélèvement

2.1 Identification

Chaque tube est étiqueté au lit du patient, immédiatement après le prélèvement, avec le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le sexe. Le bon de demande précise la date et l’heure du prélèvement ainsi que l’identité du préleveur. Un tube non identifié n’est jamais analysé.

2.2 Ordre de prélèvement

Respecter l’ordre suivant pour éviter la contamination croisée des additifs. Retourner chaque tube doucement, sans agiter, le nombre de fois indiqué.

Ordre	Tube	Couleur du bouchon	Additif	Retournements
1	Flacons d’hémoculture	—	Milieu de culture	—
2	Tube citrate	Bleu clair	Citrate de sodium 3,2 %	3 à 4
3	Tube sec avec ou sans gel	Rouge ou jaune	Activateur de coagulation	5
4	Tube hépariné	Vert	Héparine de lithium	8 à 10
5	Tube EDTA	Mauve	EDTA K2	8 à 10
6	Tube fluoré	Gris	Fluorure de sodium et oxalate de potassium	8 à 10

3. Tubes utilisés

Le tableau suivant récapitule les tubes référencés au laboratoire fictif. Les couleurs de bouchon sont celles du fournisseur actuel du laboratoire ; elles peuvent différer chez d'autres fournisseurs.

Couleur du bouchon	Type de tube	Additif	Principales analyses
Mauve	Tube EDTA	EDTA K2	NFS, réticulocytes, groupage, RAI, HbA1c, ammoniémie
Bleu clair	Tube citrate	Citrate de sodium 3,2 %	TP / INR, TCA, fibrinogène, D-dimères, anti-Xa
Noir	Tube VS	Citrate de sodium 3,8 %	Vitesse de sédimentation
Vert	Tube hépariné	Héparine de lithium	Ionogramme, potassium, créatinine, troponine, CRP, bilirubine
Jaune	Tube sec avec gel	Activateur de coagulation et gel séparateur	Sérologies, TSH, ferritine, fer sérique, vitamines
Gris	Tube fluoré	Fluorure de sodium et oxalate de potassium	Glycémie, lactate

Le tube à l'héparine d'ammonium n'est pas référencé au laboratoire fictif ; il ne doit pas être confondu avec le tube à l'héparine de lithium.

4. Catalogue des analyses

Une ligne correspond à une analyse. Une case « Tube(s) refusé(s) » vide signifie que le manuel ne se prononce pas sur les autres tubes : contacter le laboratoire.

4.1 Hématologie

Analyse	Code	Tube(s) accepté(s)	Tube(s) refusé(s)	Volume	Conservation / transport	Stabilité	Délai de rendu
NFS (hémogramme)	NFS	EDTA K2 (bouchon mauve)	Citrate, héparine de lithium	2 mL	Température ambiante	24 h à température ambiante	2 h
Réticulocytes	RETIC	EDTA K2 (bouchon mauve)		2 mL	Température ambiante	48 h à 2-8 °C	4 h
Vitesse de sédimentation (VS)	VS	Citrate 3,8 % (bouchon noir) ; EDTA K2 si analyse dans les 4 h	Tube sec	2 mL	Température ambiante	4 h	4 h
Groupe sanguin ABO-RhD (groupage)	GRP	EDTA K2 (bouchon mauve)	Tube sec, tube avec gel	4 mL	Température ambiante	7 jours à 2-8 °C	24 h
Recherche d'agglutinines irrégulières (RAI)	RAI	EDTA K2 (bouchon mauve)		4 mL	Température ambiante	72 h à 2-8 °C	24 h

4.2 Hémostase

Analyse	Code	Tube(s) accepté(s)	Tube(s) refusé(s)	Volume	Conservation / transport	Stabilité	Délai de rendu
TP / INR (taux de prothrombine)	TP	Citrate de sodium 3,2 % (bouchon bleu clair)	EDTA, héparine de lithium, tube sec	Remplir jusqu'au trait	Température ambiante, ne pas réfrigérer	24 h (tube non centrifugé)	2 h
TCA (temps de céphaline activée)	TCA	Citrate de sodium 3,2 % (bouchon bleu clair)	EDTA, héparine de lithium	Remplir jusqu'au trait	Température ambiante	4 h	2 h
Fibrinogène	FIB	Citrate de sodium 3,2 % (bouchon bleu clair)	EDTA	Remplir jusqu'au trait	Température ambiante	8 h	2 h
D-dimères	DDI	Citrate de sodium 3,2 % (bouchon bleu clair)	EDTA	Remplir jusqu'au trait	Température ambiante	8 h	2 h
Activité anti-Xa (héparinémie)	AXA	Citrate de sodium 3,2 % (bouchon bleu clair)	EDTA, héparine de lithium	Remplir jusqu'au trait	Centrifuger dans l'heure	2 h	4 h

4.3 Biochimie

Analyse	Code	Tube(s) accepté(s)	Tube(s) refusé(s)	Volume	Conservation / transport	Stabilité	Délai de rendu
Ionogramme (Na, K, Cl)	IONO	Héparine de lithium (bouchon vert) ; tube sec avec gel (bouchon jaune)	EDTA	4 mL	Température ambiante, ne pas réfrigérer	4 h avant centrifugation	2 h
Potassium	K	Héparine de lithium (bouchon vert)	EDTA, tube hémolysé	2 mL	Température ambiante, ne pas réfrigérer	4 h avant centrifugation	2 h
Glycémie à jeun	GLY	Fluorure de sodium (bouchon gris)	Tube sec non centrifugé	2 mL	Température ambiante	24 h sur fluorure	2 h
Hémoglobine glyquée (HbA1c)	HBA1C	EDTA K2 (bouchon mauve)	Citrate	2 mL	Température ambiante	7 jours à 2-8 °C	24 h
Créatinine	CREA	Héparine de lithium (bouchon vert) ; tube sec avec gel (bouchon jaune)		2 mL	Température ambiante	24 h	2 h

Analyse	Code	Tube(s) accepté(s)	Tube(s) refusé(s)	Volume	Conservation / transport	Stabilité	Délai de rendu
Calcium	CA	Héparine de lithium (bouchon vert) ; tube sec avec gel (bouchon jaune)	EDTA, citrate	2 mL	Température ambiante	24 h	4 h
Calcium ionisé	CAI	Seringue héparinée pour gaz du sang	Tube sec, tube avec gel	1 mL	Sur glace, sans bulle d'air	30 minutes	1 h
Troponine T hypersensible	TROP	Héparine de lithium (bouchon vert)	EDTA	2 mL	Température ambiante	8 h	1 h (urgence)
Lactate	LACT	Fluorure de sodium (bouchon gris)	Tube sec, héparine de lithium	2 mL	Dans la glace	15 minutes avant centrifugation	1 h
Ammoniémie	NH3	EDTA K2 (bouchon mauve)	Héparine d'ammonium	2 mL	Dans la glace, tube plein et bouché	30 minutes	1 h
CRP (protéine C réactive)	CRP	Héparine de lithium (bouchon vert) ; tube sec avec gel (bouchon jaune)		2 mL	Température ambiante	72 h à 2-8 °C	2 h
Ferritine	FERRI	Tube sec avec gel (bouchon jaune)		2 mL	Température ambiante	7 jours à 2-8 °C	24 h
Fer sérique	FE	Tube sec avec gel (bouchon jaune)	EDTA, citrate	2 mL	Prélèvement le matin	7 jours à 2-8 °C	24 h
TSH	TSH	Tube sec avec gel (bouchon jaune)		2 mL	Température ambiante	7 jours à 2-8 °C	24 h
Bilirubine totale	BILT	Héparine de lithium (bouchon vert)		2 mL	À l'abri de la lumière	24 h à l'abri de la lumière	4 h
Bilirubine conjuguée	BILC	Héparine de lithium (bouchon vert)		2 mL	À l'abri de la lumière	8 h à l'abri de la lumière	4 h
Vitamine B12	B12	Tube sec avec gel (bouchon jaune)		2 mL	À l'abri de la lumière	48 h à 2-8 °C	48 h
Folates (vitamine B9)	B9	Tube sec avec gel (bouchon jaune)		2 mL	À l'abri de la lumière	24 h à 2-8 °C	48 h

5. Cas particuliers et tubes alternatifs

5.1 Glycémie

En l’absence de tube fluoré, un tube hépariné (bouchon vert) est accepté pour la glycémie à condition d’être centrifugé dans les 30 minutes suivant le prélèvement. Au-delà de ce délai, l’échantillon est non conforme pour la glycémie.

5.2 NFS

Pour la NFS, aucun tube autre que le tube EDTA n’est accepté. Un tube citrate (bouchon bleu clair) reçu seul pour une NFS est refusé et un nouveau prélèvement est demandé. Exception : la numération plaquettaire de contrôle sur citrate, prescrite en cas de suspicion de pseudo-thrombopénie, suit sa propre fiche du catalogue informatisé.

5.3 Troponine

Depuis la version 3 de ce manuel, le tube EDTA est refusé pour la troponine T hypersensible (interférence constatée sur l’automate du laboratoire fictif). Seul le tube à l’héparine de lithium est accepté.

5.4 Ammoniémie

Prélever sans garrot prolongé, sur tube EDTA K2 placé immédiatement dans la glace. L’analyse doit être réalisée dans les 30 minutes suivant le prélèvement. Le tube à l’héparine d’ammonium est strictement refusé.

5.5 Hémostase

Les tubes citratés doivent être remplis jusqu’au trait (tolérance : 90 % du volume nominal). Un tube citrate sous-rempli est non conforme pour le TP, le TCA, le fibrinogène et les D-dimères. Lorsque le prélèvement est réalisé avec une aiguille épicrânienne, prélever d’abord un tube de purge.

5.6 Potassium et ionogramme

Ne jamais réfrigérer un tube destiné au potassium avant centrifugation : la réfrigération provoque une fausse hyperkaliémie. Un tube hémolysé est non conforme pour le potassium.

5.7 HbA1c

Le tube EDTA prélevé pour la NFS peut être utilisé pour l’HbA1c lorsque les deux analyses sont prescrites ensemble. Un tube citrate n’est pas accepté pour l’HbA1c.

6. Critères de non-conformité

Un échantillon non conforme n’est pas analysé, sauf dérogation tracée par un biologiste. Le service prescripteur est prévenu et un nouveau prélèvement est demandé. Les principales causes de non-conformité sont les suivantes.

- Identification absente, incomplète ou discordante entre le tube et le bon de demande.
- Tube inadapté à l’analyse demandée (exemple : NFS reçue sur tube citrate).
- Tube citrate sous-rempli ou trop rempli.
- Échantillon hémolysé, coagulé ou lactescent selon l’analyse.
- Délai de stabilité dépassé à réception.
- Conditions de transport non respectées (glace, abri de la lumière, température).

Non-conformité	Conduite à tenir
Tube inadapté	Refuser l’analyse concernée, demander un nouveau prélèvement sur le tube indiqué au catalogue.
Tube citrate mal rempli	Refuser les analyses d’hémostase ; les autres tubes du même patient restent analysables.
Hémolyse	Refuser le potassium et le LDH ; réaliser les autres analyses avec un commentaire.
Délai dépassé	Refuser l’analyse ; tracer l’heure de réception.
Ammoniémie non transportée dans la glace	Refuser l’analyse et demander un nouveau prélèvement.

7. Historique des versions

Version	Date	Modifications
1	01/06/2023	Création du document.
2	15/01/2025	Ajout de l’ammoniémie et du lactate.
3	01/03/2026	Troponine : tube EDTA désormais refusé. Ammoniémie : délai ramené à 30 minutes. Ajout du calcium ionisé.

Annexe A. Hémocultures et prélèvements urinaires

A.1 Hémocultures

Les flacons d’hémoculture sont prélevés en premier, après désinfection cutanée. Remplir chaque flacon avec 8 à 10 mL de sang. Les flacons sont conservés à température ambiante et acheminés au laboratoire dans les 2 heures ; ils ne doivent jamais être réfrigérés.

A.2 ECBU

L’examen cytobactériologique des urines (ECBU) est réalisé sur les urines du milieu de jet, recueillies dans un flacon stérile après toilette. Le flacon est acheminé dans les 2 heures à température ambiante, ou conservé au maximum 12 heures à 2-8 °C. Un flacon non stérile est refusé.

Annexe B. Abréviations

Abréviation	Signification
EDTA	Acide éthylène diamine tétra-acétique (anticoagulant du tube mauve)
NFS	Numération formule sanguine
TP	Taux de prothrombine
TCA	Temps de céphaline activée
RAI	Recherche d’agglutinines irrégulières
HbA1c	Hémoglobine glyquée
CRP	Protéine C réactive

Contacts

Secrétariat du laboratoire fictif : poste 0000 (numéro fictif). Biologiste de garde : poste 0001 (numéro fictif).